

Résumé : Les Strabismes Concomitants

Dr Camilia Chafter

1. Introduction et objectifs

Les strabismes concomitants représentent une part importante de l'activité orthoptique et nécessitent une approche clinique rigoureuse ainsi qu'une prise en charge précoce.

Objectifs du cours :

- Définir précisément un strabisme concomitant.
- Reconnaître les différentes formes cliniques.
- Réaliser un examen orthoptique complet et interpréter ses résultats.
- Participer à la prise en charge thérapeutique adaptée à chaque situation.

2. Rappel : Concomitant vs Incomitant

| Caractéristique | Strabisme concomitant | Strabisme incomitant |

| Angle de déviation | Constant quelle que soit la direction | Variable selon la direction du regard |

| Motilité oculaire | Conservée | Limitation ou restriction musculaire |

| Mécanisme principal | Déséquilibre du contrôle binoculaire | Paralysie ou restriction musculaire |

3. Définition

Un strabisme concomitant est une déviation permanente ou intermittente des axes visuels, dans laquelle :

- L'angle de déviation reste constant dans toutes les directions du regard.
- La motilité oculaire est conservée (pas de limitation des mouvements).
- Il traduit principalement un déséquilibre du contrôle binoculaire, et non une atteinte musculaire ou neurologique.

4. Physiopathologie

La physiopathologie repose sur une interaction complexe entre facteurs moteurs et sensoriels :

1. Défaut de fusion binoculaire → incapacité à maintenir l'alignement des yeux.
2. Anomalies de réfraction (notamment l'hypermétropie) → hyperactivité accommodative → convergence excessive.
3. Facteurs génétiques et développementaux → peuvent intervenir dans l'apparition du trouble.

5. Conséquences sensorielles

Chez l'enfant, la diplopie est rarement ressentie car le cerveau met en place des mécanismes d'adaptation :

| Mécanisme | Description |

| Suppression | Le cerveau supprime l'image de l'œil dévié pour éviter la confusion visuelle |

| Amblyopie | Conséquence à long terme d'une suppression prolongée (baisse de l'AV de l'œil non utilisé) |

| Correspondance Rétinienne Anormale (CRA) | Modification de la perception de l'espace visuel |

6. Classification

Les strabismes concomitants se classent selon plusieurs critères :

| Critère | Types |

| Direction de la déviation | Ésotropie (vers l'intérieur) / Exotropie (vers l'extérieur) |

| Mode d'apparition | Constant / Intermittent |

| Âge de survenue | Infantile (précoce) / Acquis (tardif) |

7. Rôle de l'orthoptiste

L'orthoptiste joue un rôle central à toutes les étapes :

- Dépistage et suivi après traitement.
- Mesures précises de la déviation.
- Évaluation des fonctions sensorielles.
- Mise en place de la rééducation visant à améliorer la vision binoculaire.

8. Examen orthoptique

8.1 Interrogatoire

- Âge d'apparition du strabisme et mode d'installation.
- Caractère permanent ou intermittent.
- Présence de diplopie ou de signes fonctionnels associés.
- Antécédents familiaux de strabisme ou d'amblyopie.

8.2 Inspection

- Position de la tête (torticolis compensateur éventuel).
- Qualité de la fixation.
- Présence d'un clignement excessif ou fermeture d'un œil.
- Dominance oculaire.

8.3 Cover test

Examen clinique fondamental permettant de mettre en évidence une déviation manifeste ou latente :

- Principe : occlusion d'un œil pendant que l'autre fixe une cible → observation du mouvement de refixation à la levée de l'occlusion.
- Cover test simple : révèle la tropie (strabisme manifeste).
- Cover test alterné : dissocie les yeux et mesure l'angle total de la déviation.

8.4 Mesure de l'angle

- Prismes placés devant l'œil pour neutraliser le mouvement de refixation.

- Mesure de loin et de près pour détecter des variations.
- Le synoptophore permet d'affiner la mesure et d'analyser les capacités de fusion.

8.5 Étude sensorielle

- Évaluation de la stéréoscopie (tests spécifiques).
- Permet de déterminer le potentiel de récupération fonctionnelle.

8.6 Réfraction

- Doit être réalisée sous cycloplégie (obligatoire chez l'enfant).
- Recherche d'hypermétropie (impliquée directement dans la genèse de l'ésotropie accommodative).
- La correction optique constitue souvent la première étape du traitement.

9. Types de strabismes concomitants

9.1 Ésotropies

Ésotropie infantile

- Apparition avant 6 mois.
- Angle de déviation important et constant ; alternance possible.
- Vision binoculaire absente ou très altérée.
- Signes associés fréquents : nystagmus latent, hyperaction des obliques inférieurs.
- Prise en charge : souvent chirurgicale après traitement de l'éventuelle amblyopie.

Ésotropie accommodative pure

- Liée à une hypermétropie non corrigée → accommodation excessive → convergence excessive.
- Apparaît généralement entre 2 et 4 ans.
- La déviation disparaît complètement avec la correction optique.
- Traitement : port permanent de lunettes.

Ésotropie partiellement accommodative

- La correction optique réduit l'angle mais ne l'élimine pas entièrement.
- Prise en charge combinée : correction optique + traitement de l'amblyopie + chirurgie des muscles oculomoteurs si nécessaire.

9.2 Exotropies

Exotropie : définition

- Déviation des axes visuels vers l'extérieur.
- Souvent intermittente au début, peut passer inaperçue initialement.
- La vision binoculaire est souvent partiellement conservée.
- Évolution possible vers une forme permanente sans prise en charge.

Exotropie intermittente (forme la plus fréquente)

- Déviation visible lors de : fatigue, inattention, fixation au loin, forte luminosité.
- Signes évocateurs : fermeture d'un œil en plein soleil, difficulté à maintenir la fixation.
- Prise en charge selon la fréquence et le retentissement : surveillance → rééducation → chirurgie.

9.3 Microstrabisme

- Déviation de faible amplitude (< 10 dioptries prismatiques).
- Passe souvent inaperçu à l'inspection simple.
- Fréquemment associé à une amblyopie modérée et une CRA.
- Vision binoculaire altérée mais partiellement conservée (fusion périphérique possible).
- Diagnostic : test de Lang, test de fixation excentrée.

9.4 Strabisme sensoriel

- Secondaire à une baisse de vision unilatérale (quelle qu'en soit la cause).
- La mauvaise qualité de l'image empêche le maintien de l'alignement.
- Peut être ésoptropie ou exotropie.
- Traitement : traiter la cause visuelle en priorité, puis corriger la déviation si nécessaire.

10. Traitement

10.1 Principes généraux

Les objectifs du traitement sont :

1. Obtenir un bon alignement oculaire.
2. Prévenir ou traiter l'amblyopie (priorité urgente).
3. Favoriser le développement ou la restauration de la vision binoculaire.

La prise en charge est souvent progressive, en collaboration étroite entre ophtalmologiste et orthoptiste.

10.2 Correction optique

- Première étape du traitement, surtout dans les ésootropies accommodatives.
- Port constant de lunettes prescrites après réfraction sous cycloplégie.
- Peut suffire à réaligner les axes visuels dans les formes purement accommodatives.

10.3 Traitement de l'amblyopie

- Occlusion de l'œil dominant pour stimuler l'œil amblyope.
- Alternatives : pénalisation optique ou pharmacologique.
- L'efficacité dépend de la précocité et de l'observance.

10.4 Rééducation orthoptique

- Objectif : améliorer les capacités de fusion et renforcer le contrôle de la déviation.
- Exercices de convergence, divergence et coordination binoculaire.
- Particulièrement utile dans les exotropies intermittentes et les troubles de la convergence.

10.5 Traitement chirurgical

- Indiqué en cas de déviation persistante malgré une prise en charge bien conduite.
- Techniques : recul (affaiblissement) ou résection (renforcement) des muscles oculomoteurs.
- Objectif : réaligner les axes visuels (amélioration fonctionnelle et esthétique).
- Ne dispense pas d'un suivi orthoptique post-opératoire.

11. Suivi

- Doit être régulier et prolongé.
- Surveillance de l'évolution de la déviation, de l'efficacité du traitement et du développement de la

vision binoculaire.

- Des ajustements thérapeutiques sont souvent nécessaires.

12. Cas cliniques

Cas 1 : Ésotropie accommodative avec amblyopie

- Enfant de 3 ans, déviation convergente constante apparue progressivement.
- Hypermétropie importante + amblyopie de l'œil droit.
- CAT : prescrire la correction optique adaptée + débiter le traitement de l'amblyopie. Réévaluation pour juger de la part accommodative.

Cas 2 : Exotropie intermittente

- Enfant avec exotropie visible en fin de journée et en vision de loin.
- Contrôle encore partiellement conservé.
- CAT : surveillance + rééducation orthoptique en première intention. Indication chirurgicale à discuter en cas d'aggravation ou de perte de contrôle.

13. Pièges diagnostiques à éviter

- Ne pas méconnaître un strabisme incomitant pouvant traduire une atteinte neurologique.
- Réfraction incomplète → erreur diagnostique (surtout dans les ésotropies accommodatives).
- Amblyopie : doit être systématiquement recherchée car elle peut passer inaperçue.